

MOVIMIENTOS ANORMALES EN LACTANTES								
Generalidades	■ En general aparecen durante el V año de vida ■ Idiopáticos ■ No asociados a enfermedades sistémicas ■ Autolimitados ■ No comprometen el desarrollo del niño ■ No deja secuelas ■ Exámenes complementarios normal (EEG)							
MOVIMIENTO	Temblor esencial palatino		Distonía	Spasmus	Tortícolis paroxística	Elevación	Mioclonías	Mioclonías
	Jitterines (temblor)	Shuddeesing (estremecimiento)						
Aparición	RN	más grandes	12 meses	5 m a 3 años	12 año	1 o > años	1º sem.(Muy fr)	3-9 meses
Características	Temblor del mentón y extremidades que aparece con el llanto o excitación No hay compromiso de la motilidad ocular	Sacudidas de algunos segundos de duración En la cabeza y ambos MS	Postura distónica en extremidades (miembros en suspensión)	Nistagmus horizontales asimétricos + mecanismos compensatorios Movimientos de la cabeza Inclinación cefálica Pronóstico reservado. Diferenciar con enfermedades retinianas a través de RMN	Episodios recurrentes de inclinación lateral de la cabeza. Puede asociarse a irritabilidad, vómitos, ataxia, postura anormal del tronco, nistagmus y/o palidez Más frecuente cuando hay intercurencia de infecciones	Desviación de la mirada hacia arriba Aparece nistagmus cuando baja la mirada Duración: minutos, horas, días Leve ataxia Exacerbación con fatiga, estrés, infecciones	Sacudidas mioclónicas repetitivas predominantes en miembros superiores durante el sueño lento. Hasta 30 min de duración Las Benzodiacepinas aumentan la intensidad y duración	Aparece cuando el niño está muy estimulado Ocurre en salvas
Desaparición	13 mes		18 m	en 3 a 6 meses	1-5 años	En años	3º o 4º mes de vida	durante el 1º año
Desaparición	con la flexión pasiva o con la succión		cuando realiza algún acto voluntario			al dormir	al despertar	